

Fecha Última Actualización: 17-11-2022 9:27:19

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Julian Benjamin Carvajal Quezada **Rut** : 22.215.900-8 **N° Archivo** : 1808572
Edad : 16a 1m 24d **Fecha Nacto**: 24/09/2006 **Sexo** : Masculino
Dirección : Pje. Percheron 0758 San Guillermo 0758 **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 945585702

N° Epicrisis
329121

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 17/10/2022 07:13 **Días Estadía** : 31
Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Egreso** : 17/11/2022 09:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Politraumatizado

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Resumen UPC-UCI
11/11/22

FI Hospital: 17/10/2022 (07:13)
FI UPC-UCI: 17/10/2022 (16:15)

Antecedentes:

Médicos: ninguno

Quirúrgicos: ninguno

Medicamentos: Zopiclona 7.5 mg (2 comprimidos en la noche), Venlafaxina 1 comprimido al día.

Alergias: ninguna

Hábitos: Tabaco (+) Marihuana (+)

Historia:

Paciente presenta accidente de tránsito el 17/10 durante la madrugada conduciendo motocicleta (con casco); de alta energía, choque frontal con automóvil, a alta velocidad. Es trasladado en SAMU a SU CASR donde ingresa en GSC 5. Somnoliento, sin obedecer órdenes simples. Descrito polipneico, Sat 99% ambiental. E-FAST (-) pericárdico y abdominal, torácico inconcluso para neumotórax. Posteriormente se describe en malas condiciones generales, se asiste SIR, se logra IOT al primer intento, TET 8.0 a 22 cms, ventilando simétrico. Conecto a VMI modo C/V Vt 380 FR 20 Ti 1.0 PEEP 6 Fio2 70% Sat 100% FC 130 PA 146/95, bien acoplado. Al examen físico destacó deformidad a nivel de antebrazo y herida en dorso del radio suturada. Con pulsos simétricos presentes. Múltiples erosiones profundas en región cervical anterior.

Evaluación por especialidades:

Neurocirugía: TC cerebro sin contraste les impresiona múltiples petequias subcorticales, en ganglios basales, frontales y temporal izquierdas, escasa HSA interpeduncular, cisternas y surcos presentes, no se observan fracturas.

Cirugía de trauma: Laceración hepática derecha (AAST grado III) con hematoma estable en secuencia de controles tomográficos. Que impresiona sin signos de sangrado activo. Se planteó seguimiento y aseo cervical en pabellón.

Traumatología: Intervención quirúrgica de antebrazo y pelvis en diferido. CT columna cervical sin lesión ósea aguda. CT se

Fecha Epicrisis : 17/11/2022 09:27

Página 1 de 4

evidencia fractura de radio y cubito diáfisis distal.

Cirugía máxilo facial: Herida contuso cortante de lengua y mentón, con sangrado activo. Aseo con suero, retiro de cuerpos extraños, cierre por planos Vycril de lesión de lengua y Vycril 3.0 y Ethilon 5.0 en mentón. Con hemostasia OK.

Diagnósticos de ingreso a UCI:

1. Politraumatizado

- Daño axonal difuso
- Contusiones pulmonares extensas bilaterales
- Contusión hepática grado 2
- Hemoperitoneo leve
- Hematoma del meso
- Fractura rama isquiopubiana
- Fractura radio-cubital distal

Evolución UPC- UCI

1. Hemodinamia: Paciente grave, hemodinamia límite con tendencia a la taquicardia e hipotensión a su ingreso, que responde al manejo con volumen y hemoderivados, se transfunden 4 U GR + 2 U PFC en el servicio de urgencias. En UPC con requerimiento de apoyo con drogas vasoactivas, noradrenalina a dosis bajas, sin signos de sangrado activo, sin mayor conflicto, logrando PAM sobre 65 mmHg. Mantiene monitorización invasiva, hemodinamia estable, lactato normal, hematocrito estable.

Ecocopia al ingreso UCI: Corazón con contractibilidad conservada, sin sobrecarga de cavidades derechas, impresiona derrame pericárdico mínimo. Líneas B difusas en todos los campos pulmonares, neumotórax (-). Espacio hepatorenal y esplenoarenal libres. Líquido libre en cavidad pélvica (+).

Sin conflicto en la fecha, sin vasoactivos.

2. Neurológico: TEC grave, del ingreso TC cerebro sin contraste donde impresionan múltiples petequias subcorticales, en ganglios basales, frontales y temporal izquierdas, escasa HSA interpeduncular, cisternas y surcos presentes, no se observan fracturas. Mantiene medidas de neuroprotección, sedado SAS 1, Na 140-145, normotermia y cabeza línea media 30°. Se alcanza SAS deseado con midazolam, fentanilo y propofol. Se cumple fenitoína para evitar convulsiones precoces por 7 días, luego se suspende. Valorado por equipo de neurocirugía para instalación de captor de PIC, seguimiento con TC de cerebro de control a las 72 h, con contusión temporal basal izquierda pequeña y petequiado frontal izquierdo, daño axonal difuso grado III, surcos y cisternas presentes, sin edema cerebral. Mantuvo monitoreo con captor de PIC con valores persistentes < 10, pTiO2 30-38. 25/10 retiro de captor de PIC, completó 1 semana con captor, con PICs sostenidamente bajas. TC cerebrales seriados que demuestran regresión en lesiones traumáticas focales. TC cerebro de control del 23/10 sin nuevos hallazgos de carácter agudo, contusiones temporal izquierda y mesencefálica izquierda en proceso de reabsorción, post retiro de captor sin lesiones agudas. 29/10 sin DVE, con vigilia espontánea pero escasa conexión al medio. Obedece órdenes de forma parcial a familiares.

Intercurió con delirium de difícil control que se manejó con antipsicóticos (haloperidol, quetiapina), metadona, clonidina, diazepam y dexmedetomidina. Valorado por equipo de Psiquiatría, quienes recomiendan Ac valproico para manejo de delirium multifactorial, iniciado el 04/11. Evolucionando febril 38-39°C, sin foco infeccioso activo clínico, ni microbiología aislada, por lo que se plantea probable fiebre secundaria a fármacos (Haloperidol vs Ac valproico), obs. SNM por elevación discreta de CK-T (419->255).

Se suspende ac valproico, haloperidol y clonidina el 07/11. Con buena respuesta a suspensión de fármacos y a manejo con antipiréticos. Afebril > 24 horas. Tranquilo, cooperador. En seguimiento por equipo de Neurología.

Se ajustan antipsicóticos y BZD, se mantiene Precedex 0.2.

De alta por neurocirugía el 02/11, con plan de control al alta con Dra. Oliva.

3. Traumatológico: En plan de tratamiento quirúrgico de fractura de extremidad superior y pelvis diferida hasta alcanzar estabilidad hemodinámica. El 22/10 se realiza corrección quirúrgica por traumatología, cirugía de 3 tiempos. Durante 1er tiempo quirúrgico para fijación de pelvis, se requiere posición prono con incremento de PIC hasta 31 según se describe en protocolo quirúrgico, donde requiere apoyo con drogas vasoactivas. Ingresa posterior a 6 hrs de pabellón a UCI para manejo inmediato. PIC ~25-27, con PAM 120.

25/10 En seguimiento por equipo de traumatología por estabilización quirúrgica de fracturas, al momento sin interurrencias en esta esfera. Pendiente Rx de antebrazo derecho de control.

4. Respiratorio: Se mantiene sin mayor conflicto de intercambio gaseoso, sin embargo con contusión pulmonar bilateral importante observada en tomografía de tórax, se mantiene con ventilación protectora, con adecuada mecánica ventilatoria. Proceso de weaning difícil, paciente con agitación psicomotriz al intentar despertar, se mantiene sedación para sincronías. El 29/10 dado condición y evolución favorable, se extuba. PaFiO₂ >300. Se mantiene ventilando espontáneamente, con adecuada mecánica ventilatoria.

5. Infeccioso: Paciente con fractura expuesta de antebrazo (tipo III por mecanismo de alta energía), se indica Cefazolina + Gentamicina para profilaxis ATB. Evoluciona febril, por lo que se pancultiva y escala a Meropenem + Vancomicina. De los cultivos (20/10) CAET con SAMS, se suspende Meropenem y Vancomicina y se inicia Cefazolina con plan de completar 10-14 días. Descenso de PCR 170 --> 134, afebril. Cultivos control del 23/10, HCs, UC y CAET negativos. Cumple terapia con Cefazolina hasta el 30/10 cuando presenta nuevo peak febril, por lo que se pancultiva de nuevo, se rotan invasivos y se escala terapia a Imipenem + Vancomicina. El 03/11 se suspende vancomicina dado parámetros inflamatorios en descenso, sin microbiología aislada. HCs, UC negativos, cultivo de punta de catéter (30/10) positivo para Staphylococcus capitis resistente a ciprofloxacino y cloxacilina. Evoluciona con fiebre nuevamente el 05/11 hasta 38°C. PPII bajos, PCR 2.3, cultivos del 06/11 pendientes. No impresiona foco infeccioso activo, impresiona fiebre secundaria a drogas. Completa 7 días de Imipenem y 3 días de Amikacina por SO levemente inflamatorio (leucos 4-8xc).

6. Quirúrgico. Trauma hepático, estable y sin resorte quirúrgico. Se realizó aseo de lesión cervical en pabellón junto con fijación de brazo derecho y pelvis con traumatología. Seguimiento sangrado abdominal, de mo m e nto sin indicación quirúrgica. AngioTC TAP 28/10 con leve ascitis en excavación pelviana de menor cuantía con respecto a estudio previo. Hígado de forma y tamaño normal, sin observar lesiones focales de aspecto agresivo, área de laceración hepática visualizada en estudio previo no evaluable.

Paciente Sale a sala basica de cirugia , para continuar con seguimiento por otorrinolaringologia , fonoaudiologia y KNT para rehabilitacion motora

Diagnóstico de Egreso

TRAUMATISMO DE MÚLTIPLES ÓRGANOS INTRAABDOMINALES -
TRAUM. ENCEFALO Y NERVIOS CRANEALES C/TRAUM.NERVIOS Y MEDULA ESPINAL A NIVEL DEL CUELLO -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En BCG estable sin dolor .
Sin O₂
Tolerando papilla

Plan Post Alta

- Plan:
1. regimen papilla con liquidos claros
 2. fonoterapia voz y deglucion, entrenamiento consistencia solida
 3. control por otorrinolaringologia en 1 mes, solicitar hora.
 4. KNT para rehabilitacion
 5. Terapia ocupacional
 6. Contiunuar seguimeinto por Fonoaudiologia para trastorno deglucion leve
 7. Acudir a urgencias SOS

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 17/11/2022 09:27

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 17-11-2022 9:27:19

Página 4 de 4



Glenda Ortiz Reina
Becado/Residente

INTERNO

Natalia Vega Rios
Médico Tratante (Staff)